Časová naléhavost: RUTINA *Objednal:*CHLB - Chirurgie - stanice B

Laboratorní vyšetření

Ze dne:

Pacient 7

Dat. nar.: *Č. poj.:* **723456/7777** *Kód poj.:*

Bydliště:

Histologie

B_AA Lokalizace 1 Text...

B_AA Lokalizace 1

PRŮVODNÍ LIST K ZÁSILCE BIOPTICKÉHO MATERIÁLU

Vyšetřovací číslo:
Datum odběru:0 Datum příjmu:0 Žadatel vyšetření:Datum odeslání:
Klinická diagnóza:C509
TOPOGRAFIE ODBĚRU: prs vlevo
KLIN. DIAG.:

lobul. ca. prsu - DKK při bazi prsu vlevo

preparát. porce žlázy s tumorem , u kterého je klip, mediálně modrý steh, laterálně bílý steh, ventrálně dlouhý bílý steh

DIAGNÓZA: C509
CHIRURGICKÉ VYŠ.:
lumpectomiia e mamma l.sin.

NÁLEZ:
1/1
Makropopis:
V nádobě označené "porce žlázy s TU" zaslána prstní tkáň prsní hmotnosti 50 g, velikosti 8 x 3 x 10 cm. Mediálně je přítomen mdrý steh, laterálně krátný bílý steh a ventrálně je přítomen na kožním krytu dlouhý bílý steh. Kožní kryt velikosti 6 x 0,7 cm. Námi je kraniální resekční plocha nabarvena modrou tuší, kaudální černou tuší. Ve vzdálenosti 1,5 cm od laterálního resekčního okraje se v prsní tkáni nachází tumorózní léze velikosti 0,3 x 0,3 x 0,4 cm, bělavé barvy, polotuhé konzistence. Léze je vzdálena nejméně 0,2 cm od kaudálního resekčního okraje, dále 5 cm od kraniálního esekčního, 3 cm od dorzálního resekčního okraje, 3 cm od ventrálního resekčního okraje, 4 cm od laterálního resekčního okraje.

"prs vlevo"
Mikropopis:
a-h/ V preparátech průřezy tukově vazivovým stromatem mléčné žlázy se strukturami invazivního lobulárního karcinomu, skóre dle modifikované Nottinghamské klasifikace 3+2+1=6, středně diferencovaný G2, bez přítomnosti myoepiteliální vrstvy v p63. V okolním tuku přítomny makrofágy a nekróza tukové tkáně. V IHC vyšetření jsou pozitivní protilátky GATA3 a p120 (cytoplazmaticky). Bez zastižení angioinvaze a perineurálního šíření. Resekční okraje intaktní, karcinom je od kaudální černě barvené resekční plochy vzdálen méně než 1 mm. Dále průřezy kůží krytou epidermis s drobnou seboroickou akantotickou verukou.

Imunohistochemické vyšetření (blok):

E-CAD (DAKO, klon NCH-38)..... negativní
Ki67 (Cell Marque, klon SP6)..... 5 %

ER (Novocastra, klon 6F11/2)..... 70 %
PR (Novocastra, klon 312/2)..... 0 %
Her2neu (Ventana, klon 4B5)..... 0 (ultralow)

Závěr:
1. Velikost tumoru: 6 mm v největším průměru (měřeno mikroskopicky)
2. Typ nádoru: Invazivní lobulární karcinom + LCIS (viz biopsie č. 6293/2026).
3. Grading nádoru: G2
4. Score nádoru dle modifikované "Nottinhghamské klasifikace": 3+2+1=6
5. Angioinvaze a invaze do lymfatik: Ne
6. Perineurální šíření: Ne
7. Resekční linie: Intaktní, karcinom je od černě barvené (kaudální) resekční plochy vzdálen méně než 1 mm
8. Sentinelová lymfatická uzlina: Sentinelové lymfatické uzliny bez známek malignity (2/0)
9. TNM: pT1b N0 Mx
fi

M1: M85203 KARCINOM LOBULARNI INFILTRUJICI G: P:1
M2: M72752 VERUKA SEBOROICKA AKANTOTICKA G: P:1
M3: G: P:
TOP: T0403 PRS SIN